



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
PMKP**

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TAHUN 2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Program kerja Komite Mutu ini dibuat sebagai rencana kerja komite mutu selama tahun 2026. peningkatan mutu adalah program yang disusun secara objektif dan sistematis untuk membantu menilai mutu serta kepatuhan kinerja staff dalam memberikan asuhan pada pasien di setiap unit kerjanya.

Disusun oleh:

Komite Mutu RS. Prima Husada

Malang, 16 November 2025

Disetujui oleh:

Direktur Utama PT. Disa Prima Medika



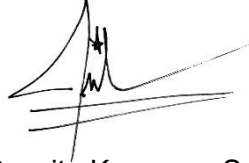
(dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE)

LEMBAR PENGESAHAN

Program Kerja Komite Mutu
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2026

Disusun oleh:

Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CHAE.)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Program Kerja Komite Mutu Rumah Sakit disusun sebagai upaya untuk terselenggaranya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh yang sepenuhnya berorientasi pada standar mutu dan keselamatan pasien serta standar akreditasi.

Program ini akan dievaluasi kembali dan akan dilakukan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi Rumah Sakit. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun program ini yang merupakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Pasuruan, 16 November
2025

Penyusun

Komite Mutu Rumah Sakit

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUANi

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISIiv

BAB I 1

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.3.1 Maksud 3

1.3.2 Tujuan4

BAB II 1

GAMBARAN UMUM1

2.1. Visi1

2.2. Misi1

2.3. Motto 1

2.4. 7 Nilai Budi Utama 1

2.5. SOTK Komite PMKP1

BAB III4

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN 4

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan4

3.2. Sasaran6

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan 20

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 202632

3.5. Kebutuhan Anggaran48

BAB IV 48

MONITORING DAN EVALUASI48

BAB V 49

PENCATATAN DAN PELAPORAN 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) adalah suatu program institusional yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Program ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menjadi prasyarat esensial dalam pemenuhan Standar Akreditasi Nasional.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah berupaya melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar yang ditetapkan. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan tahunan yang detail untuk memastikan bahwa upaya peningkatan mutu tidak bersifat insidental, melainkan terintegrasi dalam seluruh sistem pelayanan. Seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakat pun mulai berubah. Masyarakat mulai cenderung menuntut pelayanan umum yang lebih baik, lebih cepat, ramah, dan lebih bermutu, termasuk pelayanan kesehatan. Tuntutan ini menciptakan tantangan bagi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo untuk tidak hanya memenuhi standar minimal yang diwajibkan, tetapi juga untuk melampauinya dan memberikan pengalaman pelayanan terbaik (*excellent service*). Untuk merespons tuntutan ini, PMKP harus menjadi strategi utama untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing institusi.

Meskipun Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah berkomitmen melaksanakan standar PMKP, hasil evaluasi Indikator Mutu Nasional (IMN) periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kinerja (*performance gap*) signifikan di beberapa area krusial yang memerlukan intervensi programatis segera. Secara khusus, capaian di bawah target 80% dan 90% menunjukkan perlunya perbaikan mendalam pada sistem kepatuhan, yaitu Kebersihan Tangan dengan Tingkat kepatuhan berada di 79,16%, masih di bawah target dan berpotensi meningkatkan risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs). Waktu Tunggu Rawat Jalan dengan capaian hanya 71,23%, mengindikasikan rendahnya efisiensi alur pelayanan dan berpotensi menurunkan kepuasan pasien. Kepatuhan Waktu Visit Dokter: Kepatuhan terhadap waktu visit yang ditetapkan (06.00 – 14.00 WIB) hanya mencapai 75,01%, memengaruhi kualitas asuhan medis dan kesinambungan pelayanan. Sementara itu, beberapa indikator yang telah mencapai hasil baik (seperti Identifikasi Pasien 99,48%, APD 90,51%, dan Pencegahan Cedera Pasien Jatuh 97,62%) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui monitoring ketat.

Data IKP periode Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan adanya kasus-kasus risiko yang terulang seperti KPC (Kejadian Potensial Cedera) Rekam Medis Ganda dan KNC (Kejadian Nyaris Cedera) terkait Medikasi yang terulang setiap bulan. Mengenai pelaporan insiden keselamatan pasien, rumah sakit telah menunjukkan kematangan dalam fase pelaporan. Insiden- insiden ini telah dilaporkan, diinvestigasi, dan Komite PMKP telah menyelesaikan Root Cause Analysis (RCA) secara formal. Namun, nilai dari investigasi mendalam ini menjadi nihil karena ditemukan kelemahan kritis pada tahap akhir proses: Tindak Lanjut Perbaikan yang Dihasilkan dari RCA/Investigasi Seringkali Tidak Terlaksana atau berhenti di Tingkat Unit Operasional. Kegagalan implementasi ini juga ditambah dengan kelemahan pada manajemen risiko proaktif, di mana follow-up tindak lanjut dari *risk register* yang sudah dibuat belum dilaksanakan secara konsisten.

Adapun terkait hasil budaya keselamatan pasien tahun 2025 rata – rata capaian secara keseluruhan sebesar 85,85% yang menunjukkan modal budaya yang baik. Namun dari 10 dimensi budaya keselamatan terdapat 3 dimensi yang menjadi prioritas utama dalam intervensi program kerja. Pertama, yakni dimensi pelaporan kejadian keselamatan pasien dengan capaian 76,72% yang menunjukkan adanya hambatan sistemik (formulir/proses yang rumit) mereka lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal (di unit) daripada mencatatnya, sehingga rumah sakit kehilangan data krusial tentang *Near Miss* (KNC) yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran sistem. Kedua, yakni dimensi serah terima dan pertukaran informasi dengan capaian 77,73%, rendahnya koordinasi saat transisi perawatan (antar-shift atau antar-unit), yang merupakan sumber utama *medication error* dan insiden klinis. Ketiga yakni dimensi respon terhadap error yakni dengan capaian 78,81% yang menunjukkan kelemahan dalam siklus umpan balik (*feedback loop*), dan staf merasa tindak lanjut manajerial terhadap laporan insiden kurang transparan, berpotensi mengikis kepercayaan dan mengurangi motivasi pelaporan di masa depan.

Berdasarkan data Indikator Mutu Nasional (IMN) dan kegagalan di tingkat implementasi baik pada manajemen risiko, Program Kerja Komite PMKP ini disusun sebagai strategi rekayasa ulang sistem yang terfokus. Program ini bertujuan utama untuk memperbaiki Krisis Umpan Balik dengan menjamin implementasi rekomendasi RCA/investigasi dan *Risk Register* secara transparan. Selain itu, program akan berfokus pada penutupan kesenjangan kinerja pada Kebersihan Tangan dan Efisiensi Waktu Tunggu melalui penguatan pada dimensi budaya Pelaporan, Serah Terima, dan Respon terhadap *error*. Dengan demikian, program ini akan mentransformasikan risiko menjadi pembelajaran sistemik, menjamin keselamatan pasien, dan menjaga kepercayaan publik.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
- 1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
- 1.2.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan
- 1.2.7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan
- 1.2.9. Peraturan Menteri Kesehatan No 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
- 1.2.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- 1.2.12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

- 1.2.13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 1.2.14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
- 1.2.15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Elektronik)
- 1.2.16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- 1.2.17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
- 1.2.19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.2.20. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 463/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 1.2.21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.22. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/174 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Prioritas
- 1.2.23. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.25. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 1.2.26. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 262/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan program kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) ini adalah:

1. Tersedianya kerangka kerja (framework) dan panduan operasional yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan bagi Komite PMKP dan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

2. Memastikan implementasi kewajiban peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai pemenuhan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Standar Akreditasi Rumah Sakit

1.3.2 Tujuan Umum

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sesuai dengan standar indikator yang ada.
2. Menjamin terlaksananya sistem tata kelola PMKP yang transparan dan akuntabel dengan memastikan implementasi perbaikan sistemik dari insiden keselamatan pasien dan manajemen risiko, demi menjaga kepercayaan publik.
3. Membangun budaya keselamatan pasien yang proaktif dengan memperkuat dimensi Pelaporan, Serah Terima, dan Respon terhadap *Error*, untuk mencapai standar *excellent service*.

1.3.3. Tujuan Khusus

1. Tercapainya peningkatan tingkat kepatuhan kebersihan tangan (IMN) dari 79,16% menjadi minimal 85% untuk mendukung pencegahan HAIs
2. Tercapainya peningkatan efisiensi pelayanan melalui kenaikan capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan (IMN) dari 71,23% menjadi minimal 80%.
3. Tercapainya peningkatan kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 – 14.00 WIB) dari 75,01% menjadi minimal 80% guna menjamin kesinambungan asuhan medis.
4. Terpertahankannya kinerja indikator mutu yang sudah baik (Identifikasi Pasien, APD, dan Pencegahan Cedera Pasien Jatuh) pada capaian di atas 95% melalui *monitoring* berkala.
5. Terukur dan Tercapainya tingkat kepatuhan penggunaan Clinical Pathway (CP) pada kasus prioritas minimal 80%, sebagai upaya mengurangi variasi pelayanan dan memastikan *outcome* klinis yang optimal.
6. Tercapainya tingkat implementasi minimal 90% terhadap semua rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari RCA dan investigasi insiden, didukung dengan sistem *tracking* implementasi yang transparan dan akuntabel
7. Terlaksananya tindak lanjut perbaikan sistemik untuk kasus risiko yang terulang (Rekam Medis Ganda dan KNC Medikasi), dengan target penurunan frekuensi kejadian hingga 50%
8. Terlaksananya tindak lanjut dari *Risk Register* (daftar risiko) secara konsisten dan terdokumentasi, sebagai upaya mitigasi potensi risiko tinggi secara proaktif.
9. Tercapainya peningkatan dimensi Pelaporan Kejadian Keselamatan Pasien dari 76,72% menjadi minimal 85%
10. Terlaksananya standarisasi komunikasi serah terima pasien melalui implementasi protokol terstandar (misalnya SBAR), sehingga dimensi Serah Terima dan Pertukaran Informasi meningkat dari 77,73% menjadi minimal 85%
11. Terwujudnya budaya tidak menghukum (*Just Culture*) melalui pelatihan manajer unit, sehingga dimensi Respon terhadap *Error* meningkat dari 78,81% menjadi minimal 85%, dan kepercayaan staf terhadap tindak lanjut manajerial meningkat
12. Tercapainya peningkatan rata-rata capaian budaya keselamatan pasien secara keseluruhan dari 85,85% menjadi minimal 90% pada survei budaya tahunan berikutnya
13. Terlaksananya program pelatihan PMKP dengan minimal 80% total staf untuk meningkatkan kompetensi.
14. Tercapainya integrasi sistem pengumpulan, validasi, dan analisis data mutu (minimal 80% data IMN terinput dan tervalidasi setiap bulan) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan evaluasi berbasis data.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Misi

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
- 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

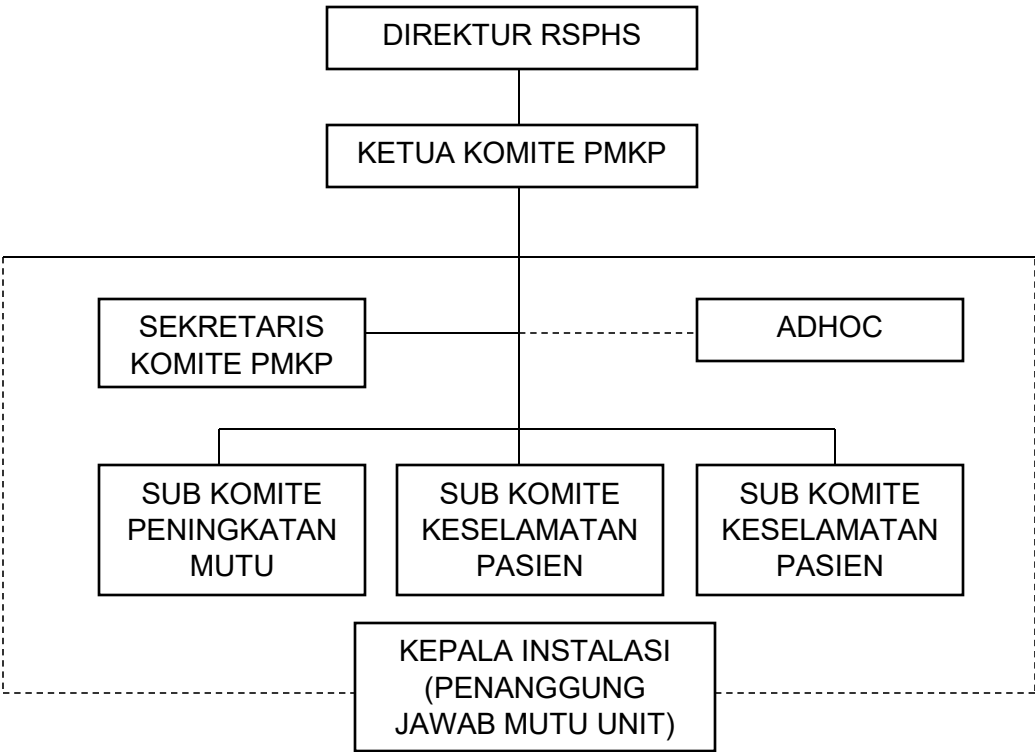
2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1. Jujur + Dipercaya
- 2. Tanggung Jawab
- 3. Visioner
- 4. Disiplin
- 5. Kerja sama
- 6. Adil
- 7. Peduli

2.5. SOTK Komite PMKP



2.6. Permasalahan kinerja tahun 2025

No	Permasalahan	Capaian	Target yang Diharapkan
1	Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan bulan Januari sampai Bulan Oktober 2025 masih di bawah standar dan berpotensi meningkatkan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIS)	79,16%	≥85%
2	Capaian Waktu tunggu pasien di Rawat Jalan sangat rendah, mengindikasikan alur pelayanan tidak efisien dan berpotensi menurunkan	71,23%	≥80%

No	Permasalahan	Capaian	Target yang Diharapkan
	kepuasan pasien secara signifikan		
3	Clinical Pathway pengisian yang patuh hanya di Unit Maternitas	Hanya maternitas yang melakukan pengisian cp dengan rata-rata kepatuhan 98,86%	Semua unit yang memiliki diagnosa tunggal bisa dilakukan evaluasi clinical pathway
4	Kepatuhan terhadap jadwal visit dokter yang telah ditetapkan masih rendah, memengaruhi kualitas asuhan medis dan kesinambungan informasi.	75,01%	≥80%
5	Kasus KPC Rekam Medis Ganda dan KNC Medikasi terulang setiap bulan.	Rekam medis ganda 66 kejadian dan <i>medication error</i> 35 kejadian	Penurunan ≤50%
6	<i>Follow-up</i> tindak lanjut dari <i>Risk Register</i> belum dilaksanakan secara konsisten	Belum dilaksanakan	Dilakukan secara konsisten
7	Standarisasi Komunikasi Serah Terima	77,73%	≥85%
8	Pelaporan insiden Keselamatan Pasien belum maksimal	76,72%	≥85%

BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Pembuatan usulan ketua Komite Mutu RSPHS: 1 orang dokter
2.	Orientasi	1. Persiapan orientasi 2. Pelaksanaan orientasi 3. Monev & pelaporan hasil orientasi
3	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu	1. Pelatihan Eksternal: a. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko b. Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) c. Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP
4.	Perencanaan Mutu RS	1. Review & Revisi Regulasi Mutu a. SK Komite Mutu b. Perdir - Pedoman Mutu RS c. SK PJ.& Validator Mutu Unit d. SK PIC Data Mutu Unit e. SK Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) f. SPO 2. Membuat Program kerja : a. Program Mutu RS (PMKP, Keselamatan Pasien, Manajemen Risiko) 3. Pengumpulan dan analisis data tahun 2025 sebagai bahan untuk pemilihan indikator Mutu tahun 2026
5.	Penetapan Indikator Mutu	1. Pengumpulan usulan mutu unit 2. Rapat koordinasi penentuan mutu Unit 3. Rapat penetapan IMPRS
		4. Penetapan dan pengesahan Indikator Mutu RS
6.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit	1. Pengukuran Indikator Mutu Nasional rutin bulanan 2. Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit rutin bulanan 3. Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit rutin bulanan 4. Melakukan validasi data pada indikator baru atau indikator yang mengalami perubahan tren signifikan 5. Menggunakan metode statistik untuk melihat tren dan perbandingan (benchmarking)
7.	Meningkatkan perbaikan mutu dan	1. Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target.

Penetapan program meliputi Point a-i

Penetapan
program
meliputi
Point a-i

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
	mempertahankan perbaikan berkelanjutan	2. Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan bertahan/stagnan).
8.	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>	1. Review kepatuhan penerapan PPK dan <i>Clinical Pathway</i> . 2. Rapat koordinasi antara Komite Mutu, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan untuk meminimalkan varian asuhan.
9.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM	1. Mengukur apakah perbaikan mutu (misal: penurunan angka infeksi atau pemendekan LOS) berdampak pada efisiensi biaya dan ketersediaan SDM. 2. Menghubungkan data mutu dengan data bagian keuangan.
10.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien	1. Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel). 2. Pelaksanaan RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan dan pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien).
11.	Penerapan sasaran keselamatan pasien	1. Monitoring 6 SKP yakni Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh. 2. Ronde keselamatan pasien secara berkala.
12.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen	1. Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar, Outsourcing, Dokter Tamu) 2. Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dalam setiap kontrak kerja sama
13.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien	1. Pelatihan Internal: a. <i>Refreshment & Training</i> PMKP b. Pelatihan Pengambilan Data Mutu (PIC): - Materi: - Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit - Alur Pengumpulan Data Mutu di <i>Google Spreadsheet</i> - Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan - Praktik mengumpulkan data Mutu baik di <i>Google Spreadsheet by name</i> - Pelatihan terkait pengisian CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite Medik) - Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi - Materi: - Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit - Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
14.	Mengkomunikasikan hasil pengukuran mutu meliputi masalah mutu dan capaian data kepada staf	1. Sosialisasi hasil capaian mutu kepada seluruh staf melalui rapat bulanan, papan pengumuman, atau media internal. 2. Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau pelaporan insiden tertinggi

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		(budaya lapor)
15.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan	1. Pelaksanaan survei budaya keselamatan minimal setahun sekali. 2. Analisis area yang masih rendah (misal: <i>non-punitive response</i>) dan edukasi staf. 3. Laporan ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik). 4. Penyusunan program budaya keselamatan untuk tahun berikutnya
16.	Pelaksanaan Pengukuran Manajemen Risiko	1. Penyusunan daftar risiko di seluruh unit. 2. Memilih satu proses berisiko tinggi untuk dilakukan analisis proaktif (FMEA). 3. Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko yang telah disusun.

3.2. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	SDM						
	Pembuatan usulan ketua Komite Mutu RSPHS: 1 orang dokter	Optimalisasi program & strategi pelaksanaan PMKP	Dokter Umum	Rekrutmen	Terpenuhi	Penambahan 1 staff untuk Ketua Komite PMKP	-
2.	Orientasi						
	1. Persiapan orientasi 2. Pelaksanaan orientasi 3. Monev & pelaporan hasil orientasi	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Pembelajaran Kontekstual	Terpenuhi	1. 100% karyawan baru mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
3.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu						
a.	Pelatihan Eksternal						
	1) Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 rencana kerja PMKP (program mutu,	Diklat diselenggarakan oleh KARS

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	manajerial tim PMKP	3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko			keselamatan pasien, atau risiko) dalam 1 bulan pasca pelatihan. 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	
	2) Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 dokumen FMEA lengkap, meliputi: a. Identifikasi mode kegagalan b. Penilaian tingkat keparahan-kejadian-deteksi c. RPN & rekomendasi perbaikan 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	Diklat diselenggarakan oleh KARS
	3) Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua Komite PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Diklat	1 kali dalam setahun	1. Peserta mampu menyusun minimal 1 indikator mutu biaya 2. Seluruh peserta mengalami peningkatan pengetahuan, dibuktikan dengan Peningkatan nilai post-test minimal 20%	Diklat diselenggarakan oleh KARS

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
4.	Perencanaan Mutu RS						
	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya	Memperbarui regulasi mutu sesuai dengan undang-undang / PMK yang berlaku	1. Komite PMKP	Review Dokumen Regulasi	1 kali dalam setahun	1. Regulasi dapat terbaru sesuai UU/PMK/Pedoman Terbaru	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Keselamatan Rumah Sakit 4) Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
5.	Penetapan Indikator Mutu						
a.	Pengumpulan usulan mutu unit	Menjaring aspirasi dan masalah mutu dari tingkat dasar	Kepala Unit & PJ Mutu Unit	Administratif	Januari 2026	Dokumen usulan indikator dari setiap unit terkumpul	
b.	Rapat koordinasi penentuan mutu Unit	Menyelaraskan usulan unit dengan ketersediaan sumber daya dan profil risiko	Komite Mutu & Kepala Unit	Koordinasi	Desember 2025	Notulen rapat kesepakatan indikator mutu unit	
c.	Rapat penetapan IMPRS	Menentukan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) berdasarkan prioritas strategis	Direksi & Komite Mutu	Strategis	Januari 2026	Terpilihnya prioritas rumah sakit	
d.	Penetapan dan pengesahan Indikator Mutu RS	Memberikan dasar hukum operasional dalam pengukuran mutu	Direktur RS	Regulasi	Januari 2026	Terbitnya SK Direktur tentang Indikator Mutu RS 2026	
6.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit						
a.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai	Sebagai tolak ukur kepatuhan dan bahan analisa capaian RS dalam menjalankan INM	Setiap Unit di RS	Observasi lapangan	Setiap bulan	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%)						
b.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko	Memilih Indikator Mutu Prioritas RS 2026 pada tahun 2025, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2026	Setiap Unit di RS	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	1. Penentuan IMP RS dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP RS dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas RS	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko						
c.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun	Memilih Indikator Mutu Prioritas Unit 2026 pada tahun 2025, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2026	Setiap unit di RS	FGD	1. Penentuan IMP Unit dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP Unit	1. Indikator Mutu Prioritas Unit terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Hemodialisa m. Radiologi n. Laboratorium o. Rehab Medis p. Farmasi q. Gizi r. Rekam Medis s. Limbah-K3RS				dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan		

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	t. SDM u. Kesekretariatan v. Driver w. Pemulasaran Jenazah x. ATEM-IPSRS y. Laundry z. CSSD aa. Cleaning Service ab. Keamanan ac. Gudang Umum ad. PPI ae. PKRS af. Verifikator ag. Humas & Marketing ah. MOD-MPP-PIPP ai. TB di IRJA aj. Keuangan ak. HIV al. KB am. Stunting an. IT-SIMRS						
d	Melakukan validasi data pada indikator baru atau indikator yang mengalami perubahan tren signifikan	Menjamin objektivitas dan kebenaran data sebelum dipublikasikan	Validator Data Unit	Validasi	100% Indikator Baru	Berita acara validasi data tersedia	
e	Menggunakan metode statistik untuk melihat tren dan perbandingan (<i>benchmarking</i>)	Memberikan gambaran performa RS dibandingkan standar atau RS lain	Komite Mutu	Analisis	Triwulanan	Tersedianya grafik tren (Run Chart) dan hasil benchmark	
7.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
a.	Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>) pada indikator yang tidak mencapai target	Melakukan uji coba perbaikan secara terstruktur pada area bermasalah	Unit Pelayanan/ Penunjang	Teknis	Sesuai hasil capaian	Adanya form PDSA yang terisi lengkap	
b.	Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan (apakah perbaikan bertahan/stagnan)	Memastikan perbaikan yang dilakukan bersifat permanen (tidak stagnan)	Komite Mutu	Monitoring	Triwulanan	Terjadi tren peningkatan capaian pada bulan berikutnya	
8.	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>						
a	Review kepatuhan penerapan PPK dan <i>Clinical Pathway</i> (CP)	Menilai sejauh mana dokter/perawat patuh terhadap panduan klinis	DPJP & Perawat	Audit Medis	Bulanan	Dokumen audit CP tersedia	
b	Rapat koordinasi antara Komite Mutu, Komite Medik, dan Bidang Keperawatan untuk meminimalkan varian asuhan	Mencari solusi atas kendala lapangan yang menyebabkan varian asuhan	Komite Medik & Keperawatan	Koordinasi	Semesteran	Notulen rapat koordinasi dan tindak lanjut perbaikan	
9.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM						
a	Mengukur apakah perbaikan mutu (misal: penurunan angka infeksi atau pemendekan LOS) berdampak pada efisiensi biaya dan ketersediaan SDM	Membuktikan bahwa peningkatan mutu mengurangi pemborosan (waste)	Unit Prioritas	Analisis	100% IMPRS	Data penghematan biaya operasional	
b	Menghubungkan data mutu dengan data bagian keuangan	Mengintegrasikan laporan klinis dengan performa finansial RS	Manajemen Keuangan	Koordinasi	Tahunan	Laporan korelasi mutu-biaya	
10.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
a	Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel)	Memudahkan staf dalam melaporkan insiden tanpa rasa takut (No Blame)	Seluruh Unit	Budaya	Real-time	Tersedianya laporan insiden dari unit	
b	Pelaksanaan RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) untuk insiden signifikan dan Pelaporan berkala ke KNKP (Komite Nasional Keselamatan Pasien)	Menemukan akar masalah insiden serius untuk perbaikan sistem	Komite Keselamatan Pasien	Investigasi	Max 45 Hari	Laporan RCA & bukti input ke aplikasi KNKP	
11.	Penerapan sasaran keselamatan pasien						
a	Monitoring 6 SKP yakni Identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, kepastian lokasi operasi, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh.	Memastikan identifikasi, komunikasi, obat, operasi, infeksi, & jatuh aman	Pasien & PPA	Observasi	Bulanan	Laporan bulanan kepatuhan SKP	
b	Ronde keselamatan pasien secara berkala	Melihat langsung penerapan standar keselamatan di lapangan	Direksi & Komite Mutu	Supervisi	Minimal 1x/bulan	Temuan ronde ditindaklanjuti oleh unit	
12.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen						
a.	Melakukan evaluasi mutu layanan yang diberikan oleh pihak ketiga (misal: Laboratorium luar	Menilai kinerja vendor berdasarkan standar mutu RS	Penunjang Medis	Audit	100% Mitra	Laporan evaluasi berkala	
b.	Penetapan KPI dalam setiap kontrak kerja sama	Menstandarisasi indikator keberhasilan dalam dokumen kontrak	Bagian Pengadaan/ Umum	Administrasi	100% Kontrak	Klausul mutu/KPI tercantum dalam PKS	
13.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien						
a.	Pelatihan Internal						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1) <i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien c) Manajemen Resiko	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
	2) Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di	Meningkatnya kemampuan PIC Mutu Unit dalam pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	PIC Mutu Unit	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya 2. Semua PIC mutu mendapatkan sertifikat pelatihan pengambilan data mutu	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	<i>Google Spreadsheet</i> c) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di <i>Google Spreadsheet by name</i>.						
	3) Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b) Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Meningkatnya kemampuan PPA (Profesional Pemberi Asuhan) pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PPA dapat mengisi Form CP 2. Semua PPA mendapatkan sertifikat pelatihan pengisian CP	
14	Komunikasi hasil pengukuran mutu kepada staf						
a.	Sosialisasi capaian mutu (rapat bulanan, papan pengumuman, media internal)	Memastikan data mutu tersampaikan secara visual dan verbal kepada staf	Seluruh Unit Kerja	Sosialisasi	Tanggal 15 tiap bulan	Terpasangnya visualisasi data (grafik) di area staf	
b.	Pemberian <i>reward</i> bagi unit dengan capaian mutu terbaik atau	Memotivasi unit untuk terus berprestasi dan	Unit Kerja & Individu	Apresiasi	Semesteran / Tahunan	Meningkatnya jumlah laporan insiden dan kepatuhan data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	pelaporan insiden tertinggi (budaya lapor)	berani melaporkan insiden					
15.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan						
a.	Pelaksanaan survei budaya keselamatan minimal setahun sekali	Mengumpulkan data persepsi keamanan dan dukungan manajemen dari staf	Medis & Non-Medis	Survei	Min. 80% Responden	Kuesioner (AHRQ) terisi lengkap	
b.	Analisis area rendah (misal: <i>non-punitive</i>) dan edukasi staf	Memperbaiki dimensi budaya yang lemah agar staf berani melapor tanpa rasa takut	Unit dengan Skor Rendah	Perbaikan	Sesuai hasil survei	Adanya bukti sosialisasi/edukasi tindak lanjut	
c.	Laporan ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik)	Memberikan laporan komprehensif kepada pimpinan untuk dukungan kebijakan	Direksi & Pemilik	Manajerial	Semesteran/ Tahunan	Laporan tertulis diterima & didisposisi	
d.	Penyusunan program budaya keselamatan tahun berikutnya	Merancang strategi penguatan budaya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan	Komite Mutu & SDM	Perencanaan	Desember 2026	Dokumen program kerja budaya keselamatan baru	
16.	Pengukuran Manajemen Risiko						
a.	Penyusunan daftar risiko (<i>Risk Register</i>) di seluruh unit	Mendokumentasikan semua potensi risiko klinis maupun non-klinis	Kepala Unit & PJ Mutu	Administrasi	Januari - Maret	Tersedianya dokumen <i>Risk Register</i> Unit	
b.	Memilih satu proses berisiko tinggi untuk dilakukan analisis proaktif (FMEA)	Menganalisis titik lemah pada proses pelayanan yang paling kritis	Tim FMEA / Unit Terkait	Investigasi	1 Dokumen/tahun	Laporan FMEA lengkap dengan desain ulang proses	
c.	Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko	Memastikan langkah pencegahan yang	Unit Kerja	Monitoring	Triwulanan	Checklist mitigasi terisi dan risiko terkendali	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	yang telah disusun	direncanakan benar-benar dijalankan					

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Pemenuhan Kebutuhan SDM						
	Pembuatan usulan ketua Komite Mutu RSPHS: 1 orang dokter	Mengajukan kebutuhan dokter umum untuk posisi Ketua Komite PMKP	Rekrutmen	Surat Usulan & Nota Dinas	Januari 2026	1. SK Direktur tentang Penunjukan Ketua Komite	
2.	Orientasi						
	a. Persiapan orientasi b. Pelaksanaan orientasi c. Monev & pelaporan hasil orientasi	Memberikan materi dasar PMKP pada masa pengenalan karyawan	Pembelajaran Kontekstual	Materi PPT & Modul	Menyesuaikan Rekrutmen	1. Daftar Hadir & Hasil Pre-Post Test	
3.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu						
	Diklat Eksternal:						
a.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Mengirimkan pimpinan Komite Mutu untuk pelatihan bersertifikat	Diklat (Workshsop)	- Lembaga Eksternal (KARS)	1x dalam setahun	1. Sertifikat Pelatihan & Dokumen Rencana Kerja	
b.	Pelatihan Penyusunan <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> (FMEA) dan <i>Root Cause Analysis</i> (RCA)	1. Mengirimkan pimpinan Komite Mutu untuk pelatihan bersertifikat	Diklat (Workhsop)	- Lembaga Eksternal (KARS)	1x dalam setahun	1. Sertifikat Pelatihan & Dokumen Rencana Kerja	
c.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Mengirimkan pimpinan Komite Mutu untuk	Diklat (Workhsop)	Lembaga Eksternal (KARS)	1x dalam setahun	Sertifikat Pelatihan & Dokumen Rencana Kerja	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		pelatihan bersertifikat					
4.	Perencanaan Mutu RS						
	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i>. Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit	Melakukan tinjauan pada SK, Pedoman, dan Program Kerja agar sesuai UU	Review Dokumen	Rapat Tim	Januari 2026	Dokumen Regulasi yang telah Disahkan (Update)	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
5.	Penetapan Indikator Mutu						
a.	Pengumpulan usulan mutu unit	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	
b.	Rapat koordinasi penentuan mutu Unit	Melakukan pemantauan CP Pasien dengan membandingkan observasi lapangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	
c.	Rapat penetapan IMPRS	Melaporkan insiden yang terjadi di unit menggunakan form laporan dan billing RS	Laporan langsung / tidak langsung	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2026	UMANDOK	
d.	Penetapan dan pengesahan Indikator Mutu RS	Melakukan survei secara online menggunakan	Survey	Instrumen pangambilan data	November 2026	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		google form dengan sasaran seluruh petugas					
6.	Pengukuran Mutu Indikator termasuk INM, IMP RS dan IMP Unit						
a.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%)						
b.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko						
c.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit	Melakukan pengumpulan data harian dan rekapitulasi bulanan	Observasi & Analisis Statistik	Spreadsheet	Setiap Bulan	Laporan Capaian Mutu & Hasil Validasi Data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponsek j. Neonatologi k. ICU l. Hemodialisa m. Radiologi n. Laboratorium o. Rehab Medis p. Farmasi q. Gizi r. Rekam Medis s. Limbah-K3RS t. SDM u. Kesekretariatan v. Driver w. Pemulasaran Jenazah						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	x. ATEM-IPSRs y. Laundry z. CSSD aa. Cleaning Service ab. Keamanan ac. Gudang Umum ad. PPI ae. PKRS af. Verifikator ag. Humas & Marketing ah. MOD-MPP-PIPP ai. TB di IRJA aj. Keuangan ak. HIV al. KB am. Stunting an. IT-SIMRS 1. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data 2. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 3. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 4. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja						
d	Validasi data pada indikator baru atau perubahan tren signifikan	Melakukan cek silang antara pengumpul data dan validator pada indikator baru	Verifikasi Data	Lembar Validasi	Tiap Triwulan	Berita Acara Validasi Data	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
e	Analisis tren dan perbandingan (<i>benchmarking</i>) dengan metode statistik	Membandingkan data capaian dengan standar atau RS lain secara statistik	Analisis Komparatif	Grafik Tren (Run Chart)	Tiap Triwulan	Laporan Analisis & Rekomendasi	
7.	Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan						
a.	Penerapan siklus PDSA (<i>Plan-Do-Study-Action</i>)	Melakukan uji coba perbaikan pada indikator yang tidak mencapai target	Siklus PDSA	Form PDSA	Sesuai Hasil Capaian	Dokumen PDSA & Laporan Evaluasi	
b.	Evaluasi keberhasilan tindak lanjut perbaikan	Memantau apakah hasil PDSA memberikan dampak peningkatan capaian	Monitoring & Evaluasi	Lembar Observasi / Dashboard Mutu	Tiap Triwulan	Laporan Evaluasi Pasca Perbaikan	
8.	Mengurangi varian dalam praktek klinis dengan menerapkan PPK/Algoritme/Protokol dan melakukan pengukuran dengan <i>clinical pathway</i>						
a	Review kepatuhan penerapan PPK & Clinical Pathway (CP)	Melakukan audit kepatuhan PPA terhadap panduan praktik klinis	Audit Medis	Lembar Audit CP	Setiap Bulan	Laporan Audit CP & Notulen Koordinasi	
b	Rapat koordinasi Komite Mutu, Medik, & Keperawatan						
9.	Mengukur dampak efisiensi dan efektivitas prioritas perbaikan terhadap keuangan dan sumber daya misalnya SDM						
a	Pengukuran dampak perbaikan (misal: LOS/Infeksi) ke biaya	Mengukur dampak perbaikan mutu terhadap penghematan biaya RS	Analisis Dampak Keuangan	Laporan Keuangan & Mutu	Tahunan	Laporan Efisiensi (Cost-Benefit Analysis)	
b	Menghubungkan data mutu dengan data keuangan	Rapat koordinasi Komite Mutu,	Membahas kendala implementasi	Rapat Koordinasi	Undangan & Notulen	Tiap Semester	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		Medik, & Keperawatan	Clinical Pathway di lapangan				
10.	Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien						
a	Penguatan alur pelaporan insiden (KNC, KTD, KTC, KPC, Sentinel)	Penguatan alur pelaporan dan investigasi insiden keselamatan pasien	Investigasi (RCA)	Aplikasi KNKP / Form IKP	Real-time	Laporan Insiden & Laporan RCA	
b	Pelaksanaan RCA & Pelaporan ke KNKP	Pelaksanaan RCA & Pelaporan ke KNKP	Melakukan investigasi mendalam untuk insiden Sentinel/KTD signifikan	Root Cause Analysis	Form RCA Eksternal	Max 45 hari pasca insiden	
11.	Penerapan sasaran keselamatan pasien						
a	Monitoring rutin 6 SKP di unit pelayanan	Monitoring 6 SKP dan ronde keselamatan pasien secara terjadwal	Supervisi & Ronde	Checklist SKP	Setiap Bulan	Laporan Monitoring SKP & Temuan Ronde	
b	Ronde keselamatan pasien (Patient Safety Walkthrough)	Kunjungan lapangan jajaran Direksi untuk melihat budaya keselamatan	Observasi Langsung	Checklist Ronde SKP	Minimal 1x/bulan	Laporan Temuan Ronde & Tindak Lanjut	
12.	Evaluasi kontrak klinis dan kontrak manajemen						
a.	Evaluasi mutu layanan pihak ketiga (Lab, Outsourcing, dll)	Menilai kualitas layanan pihak ketiga (Lab luar, Outsourcing) sesuai KPI	Audit & Review	Lembar Evaluasi Kontrak	Tiap Semester	Hasil Evaluasi Vendor & Notulen Review	
b.	Penetapan KPI dalam setiap	Memastikan	Review Kontrak	Dokumen PKS	Tiap Semester	Lampiran KPI	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	kontrak kerja sama	klausul mutu tercantum dalam perjanjian kerjasama (PKS)				pada Dokumen PKS	
13.	Pelatihan semua staf sesuai perannya dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien						
a.	Pelatihan Internal						
	1) <i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan Pasien Manajemen Resiko	Melakukan pelatihan ulang bagi seluruh staf terkait mutu dan keselamatan	In-House Training	PPT & Praktik Langsung	1x dalam setahun	Daftar Hadir & Laporan Hasil Diklat	
	2) Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: e) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit f) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di <i>Google Spreadsheet</i> g) Cara analisa permasalahan sesuai	Melakukan pelatihan ulang bagi seluruh staf terkait mutu dan keselamatan	In-House Training	PPT & Praktik Langsung	1x dalam setahun	Daftar Hadir & Laporan Hasil Diklat	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 3) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di <i>Google Spreadsheet by name</i> .						
	4) Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: c) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 5) Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Melakukan pelatihan ulang bagi seluruh staf terkait mutu dan keselamatan	In-House Training	PPT & Praktik Langsung	1x dalam setahun	Daftar Hadir & Laporan Hasil Diklat	
14	Komunikasi hasil pengukuran mutu kepada staf						
a.	Sosialisasi capaian mutu (rapat bulanan, papan pengumuman, media internal)	Sosialisasi capaian dan pemberian apresiasi bagi unit terbaik	Sosialisasi	Papan Data / Rapat Rutin	Tanggal 15 tiap bulan	Undangan & Foto Publikasi Data	
b.	Pemberian <i>reward</i> bagi unit terbaik dan budaya lapor tertinggi						
15.	Pelaksanaan Pengukuran Budaya Keselamatan						
a.	Pelaksanaan survei budaya keselamatan	Mengukur persepsi staf terhadap budaya keselamatan pasien	Survei	Kuesioner (Google Form)	1x dalam setahun	Laporan Analisis Budaya Keselamatan	
b.	Analisis area rendah (misal: <i>non-punitive</i>) & edukasi staf	Melakukan <i>brainstorming</i> pada dimensi budaya	Edukasi Terfokus	Sosialisasi Unit	Pasca Survei	Bukti Sosialisasi & Materi Perbaikan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		keselamatan yang lemah					
c.	Pelaporan hasil ke Direktur dan PT. DPM (Pemilik)	Memaparkan hasil survei budaya untuk mendapatkan dukungan manajerial	Presentasi Laporan	Laporan Tertulis	Tahunan	Tanda Terima Laporan & Notulen Paparan	
d.	Penyusunan program budaya keselamatan tahun berikutnya	Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan evaluasi budaya keselamatan	Perencanaan	Dokumen Program	Desember 2026	Draf Program Kerja Mutu 2027	
16.	Pengukuran Manajemen Risiko						
a.	Penyusunan daftar risiko (<i>Risk Register</i>) di seluruh unit	Menyusun daftar risiko unit dan analisis proaktif pada proses kritis	Identifikasi & Analisis Risiko	Form Risk Register / FMEA	Jan-Mar & 1x/tahun	Dokumen Risk Register & Dokumen FMEA	
b.	Analisis proaktif proses berisiko tinggi (FMEA)	Analisis proaktif proses berisiko tinggi (FMEA)	Membedah satu proses berisiko tinggi untuk dicegah kegagalannya	Diskusi Tim FMEA	Form FMEA	1x dalam setahun	
c.	Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko	Evaluasi kepatuhan terhadap mitigasi risiko	Memastikan seluruh unit menjalankan langkah pencegahan di <i>Risk Register</i>	Monitoring Kepatuhan	Lembar Monitoring	Tiap Triwulan	

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Dokter Umum		√												RSPHS	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
2	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Tentatif menyesuaikan Jadwal Orientasi dari SDM RS Prima Husada Sukorejo												Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-		
3	Diklat Eksternal (KARS/Lainnya)																		
a.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika		
b.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika		

	Root Cause Analysis (RCA)	Keselamatan Pasien																	
c.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS													Zoom	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
4.	Perencanaan Mutu (Review Regulasi/SK)		√														Komite PMKP		
5.	Penetapan Indikator Mutu		√														Komite PMKP		
a.	Pengumpulan usulan unit		√														Komite PMKP		
b.	Rapat koordinasi penentuan unit		√														Komite PMKP		
c.	Rapat penetapan IMP-RS		√														Komite PMKP		
d.	Pengesahan SK Indikator		√														Komite PMKP		
6.	Pengumpulan data Mutu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP		
a.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP		

	informasi mutu secara nasional.																	
b.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS): Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
c.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	

	dari minimal 1 indikator:																	
d	Validasi Data		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
e	Analisis Tren & Benchmarking			√			√			√			√				Komite PMKP	
7	Perbaikan Mutu (PDSA)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
8.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
a.	Audit Clinical Pathway (CP)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
b.	Rapat koordinasi Komite Medik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
9.	Analisis Efisiensi (Kendali Biaya)		√												√		Komite PMKP	
10.	Pelaporan Insiden (SP2KP/IKP)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
11.	Monitoring Sasaran Keselamatan Pasien		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
12.	Evaluasi Kontrak Klinis/Manajemen		√						√						√		Komite PMKP	
13	Pelatihan Internal (In-House Training)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP	
	a. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-
	b. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-

	c. 3) Pelatihan Pengisian CP	Komite Medik Komite PMKP															Komite PMKP Komite Medik		
14.	Komunikasi & Sosialisasi Capaian Mutu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Komite PMKP		
15.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun.													√			Komite PMKP		
	a. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	All Karyawan RSPH Sukorejo												√		Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Komite PMKP												√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
16	Manajemen Risiko		√																
	a. Penyusunan Risk Register	All Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP Komite PPI Komite K3RS	-	-
	b. Analisis FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Monitoring Mitigasi Risiko	Komite PMKP	√						√						√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	5	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	3	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	3	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Internal	3	Rp 100.000	Rp 300.000
5	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan c. Manajemen Resiko	Internal	2	Rp 150.000	Rp 300.000
6	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik	Internal	1	Rp 100.000	Rp 100.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name.</i> e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
7	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>	Internal	1	Rp 100.000	Rp 100.000
8	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
9	Penggunaan Platform Quizizz untuk Pelatihan Pre-Test dan Post-Test	Internal	12	Rp 1.254.000	Rp 15.048.000
TOTAL					Rp 62.348.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1.1. Monitoring

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan monitoring Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan program mutu di unit kerja
2. Monitoring, supervisi dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu
3. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja
4. Monitoring, supervisi dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja

1.2. Evaluasi

Sesuai dengan Permenkes No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit, kegiatan evaluasi Komite PMKP dilakukan dalam bentuk:

1. Rapat rutin dengan PIC Data Unit terkait capaian indikator mutu unit setiap bulan
2. Rapat Triwulanan dengan Kepala Ruang dan Jajaran Manajemen terkait capaian indikator mutu, insiden keselamatan pasien yang ada di unit
3. Pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit
4. Rapat pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator
5. Rapat pemilihan risk register unit dengan Kepala Ruang, Seluruh Komite dan jajaran Manajemen untuk dilakukan profil register.
6. Motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien
7. Melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien
8. Evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali oleh bidang bagian dan dianalisa setiap triwulan, untuk di berikan rekomendasi dan di sampaikan kepada Pemilik (Direktur PT)
9. Setelah ada feedback maka disampaikan melalui direktur ke Komite Mutu, Komite Mutu menyampaikan feedback kepada manajer untuk ditindak lanjuti

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Kegiatan pengumpulan data indikator mutu di lakukan oleh PIC data unit dengan menggunakan worksheet yang ada di google yang ada di google drive
2. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh kepala instalasi dan dilihat apakah sudah sesuai dengan profil indikator atau belum.
3. Setiap capaian indikator di rekapitulasi setiap bulan, dilengkapi dengan analisa dan tindak lanjut.
4. Setiap tiga bulan, data tersebut direkap dan dianalisis oleh manajer menjadi laporan triwulan sebagai bentuk evaluasi unit.
5. Komite Mutu bertugas melakukan validasi data hasil kegiatan jika hasil kegiatan jika ada data yang harus dievaluasi sesuai kebutuhan dalam prosedur validasi.
6. Setelah data valid maka laporan dari hasil analisa analisa setiap unit direkap menjadi laporan hasil kegiatan rumah sakit, Direktur RS melaporkan kepada Direktur PT Pemilik RS
7. Setelah ada Feedback dari Direktur PT Pemilik RS kepada Direktur RS maka disosialisasikan kepada semua manajer untuk penyusunan tindak lanjut dan diinformasikan kepada semua staf diunit kerja.
8. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari setiap kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan, hasil evaluasi disampaikan oleh Komite Mutu dan diserahkan ke Direktur PT Pemilik RS untuk ditindaklanjuti.

BAB VI PENUTUP

Demikian program kerja Komite Mutu disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun.